

ΟΞΕΙΑ ΟΡΧΙΤΙΔΑ – ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ

Γενικά: Ως ορχίτιδα ορίζεται η φλεγμονή του όρχεως, μονομερώς ή αμφοτερόπλευρα, που συνήθως προκαλείται από ιούς και βακτήρια. Η ορχίτιδα είναι είτε οξεία και συμπτωματική, είτε χρονία και ασυμπτωματική. Η μεμονωμένη ορχίτιδα είναι σπάνια και συνηθέστερα συνοδεύεται από φλεγμονή και της επιδιδυμίδας (**ορχεοεπιδιδυμίτιδα**). Η κύρια οδός εξάπλωσης είναι η αιματογενής διάδοση για τη μεμονωμένη ορχίτιδα. Ενίοτε, ανιούσες τοπικές λοιμώξεις των μαλακών μορίων μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τους όρχεις και το όσχεο, με ιδιαίτερα βαριά εικόνα (*νόσος Fournier ή κεραυνοβόλος γάγγραινα οσχέου*).

Διάφορα βακτήρια και ιοί προκαλούν ορχεοεπιδιδυμίτιδα (Ο/Ε). Η Ο/Ε σε νεαρούς ασθενείς είναι συνήθως ιογενής, με την παρωτίτιδα (*Mumps*) και την ερυθρά (*Rubella*) να είναι οι πλέον συχνές αιτίες. Υπάρχουν αναφορές περιπτώσεων Ο/Ε μετά τον εμβολιασμό για ιλαρά - παρωτίτιδα - ερυθρά (*MMR*). Άλλοι υπεύθυνοι ιοί είναι οι ιοί coxsackie, της ανεμευλογιάς (*VZV*), ιοί echo και ο κυτταρομεγαλοϊός (*CMV*). Ορχίτιδα αναπτύσσεται στο 14-35% των μετεφηβικών ασθενών με παρωτίτιδα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 4-8 ημέρες μετά την παρωτίτιδα, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστούν και επί απουσίας εμφανούς νόσου των παρωτίδων. Ο ιός της παρωτίτιδας (*σπανιότερα πλέον η σύφιλη*) θεωρείται σήμερα υπεύθυνος για τις περισσότερες περιπτώσεις μεμονωμένης ορχίτιδας.

Βακτηριακές λοιμώξεις του προστάτη και ουρολοιμώξεις μπορεί να προκαλέσουν ορχίτιδα. Κοινές αιτίες βακτηριακής ορχίτιδας περιλαμβάνουν τα είδη: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* και στελέχη *Staphylococcus spp* και *Streptococcus spp*. Βακτήρια υπεύθυνα για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν να προκαλέσουν ορχίτιδα σε σεξουαλικά ενεργούς άνδρες (π.χ. *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Treponema pallidum*). Επίσης, το *Mycobacterium avium complex*, ο *Cryptococcus neoformans*, το *Toxoplasma gondii*, ο *Haemophilus parainfluenzae* και η *Candida albicans* έχουν ενοχοποιηθεί για ορχίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Κοινοί παράγοντες κινδύνου θεωρούνται, το προϋπάρχον ιστορικό Ο/Ε, οι σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις, οι πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι, η μακροχρόνια χρήση ουροκαθετήρα Foley, η απόφραξη εξόδου της ουροδόχου κύστεως, οι δομικές ανωμαλίες του ουροποιογεννητικού συστήματος και η έλλειψη ανοσοποίησης με εμβολιασμό MMR.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής αναφέρει οξείας έναρξης, έντονο άλγος στους όρχεις, το οποίο μπορεί αρχικά να αφορά στον έναν όρχι και εν συνεχεία μπορεί να επεκταθεί και να περιλαμβάνει ολόκληρο το όσχεο. Συχνά συνυπάρχει πυρετός, ενίοτε με ρίγος, ναυτία, έμετοι, κακουχία και κόπωση. Στη φυσική εξέταση ανευρίσκεται διόγκωση των όρχεων, ευαισθησία και σκλήρυνση. Συχνά υπάρχει οίδημα και ερύθημα ολόκληρου του οσχέου. Η επιδιδυμίδα συχνά διογκώνεται εφόσον η ορχίτιδα συνοδεύεται από επιδιδυμίτιδα (Ο/Ε). Ο ασθενής μπορεί να νιώθει ανακούφιση κατά την ανύψωση των όρχεων σε κατακεκλιμένη θέση (*θετικό σημείο Prehn*). Το αντανakλαστικό του κρεμαστήρα μυός (*ανάσπαση του όρχεως μετά από ερεθισμό της μηροβουβωνικής πτυχής ή της έσω μηριαίας χώρας ή του οσχέου*) είναι φυσιολογικό στους ασθενείς με Ο/Ε (*ενώ καταργείται επί συστροφής όρχεως*).

Η διάγνωση της Ο/Ε γίνεται από το ιστορικό και τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γενικά δεν είναι χρήσιμες, αλλά εκτός από τον συνήθη έλεγχο (*γενική αίματος, CRP, Urea, Creat.*) μπορούν να ληφθούν επίχρισμα ουρήθρας και δείγμα ούρων για εξετάσεις ρουτίνας, καλλιέργειες και αντιβιογράμματα, ώστε να αποκλειστεί η ουρολοίμωξη και να διαγνωσθεί μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη ως αιτία της Ο/Ε.

Κατά την αξιολόγηση των ασθενών με έντονο και οξύ άλγος στους όρχεις ή στο όσχεο, κρίνεται αναγκαίο να αποκλειστεί αρχικά η συστολή όρχεων. Για αυτούς τους ασθενείς, η έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία (U/S) όρχεων-οσχέου είναι η εξέταση πρώτης επιλογής. Τα U/S ευρήματα σε ασθενείς με Ο/Ε από παρωτίτιδα συνήθως υποχωρούν την 7^η ημέρα.

Διαφορική διάγνωση: θα γίνει από τη συστολή όρχεως (*απαιτεί επείγουσα διερεύνηση και αντιμετώπιση*) το απόστημα, την υδροκήλη, τον καρκίνο του όρχεως (*ενίοτε εμφανίζει οξύ άλγος λόγω αιμορραγίας εντός του όγκου*) και την επιδιδυμίτιδα που συχνά συνυπάρχουν.

Θεραπευτική παρέμβαση

Ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης είναι πρωτίστως η διάκριση μεταξύ φλεγμονής και συστροφής του όρχεως, η οποία απαιτεί επείγουσα ουρολογική αντιμετώπιση. Αφού αυτό διαφοροδιαγνωσθεί και αποσαφηνιστεί με βεβαιότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προχωρούμε κατόπιν στη θεραπευτική παρέμβαση επί της φλεγμονώδους καταστάσεως.

Τα αντιβιοτικά σαφώς και δεν κρίνονται απαραίτητα για τις ιογενείς αιτίες της νόσου. Εφόσον όμως ο ασθενής παρουσιάζει τοξική εμφάνιση ή εικόνα σηπτικής κατάστασης, τότε απαιτείται η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών, τουλάχιστον κατά την 1^η και 2^η δόση και παραμονή στη Μονάδα Βραχεία Νοσηλείας (MBN) του ΚΥ ή εισαγωγή σε νοσοκομείο.

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, θερμοκρασία, RR, SpO₂) και διερευνούμε για επιβαρυντικούς παράγοντες που πιθανώς απαιτήσουν την παραπομπή και νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο, τουλάχιστον αρχικώς, για 1-3 ημέρες.
2. Τοποθετούμε ευρεία 3-way φλεβική γραμμή, για έναρξη της ΕΦ αντιβιοτικής αγωγής. Ενυδατώνουμε τον ασθενή στην αρχή της θεραπείας – εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο ή αν βρίσκεται σε τοξική κατάσταση – με 500-1000 ml NaCl 0,9% ή R/L ή R/S, αναλόγως των αναγκών και ελέγχοντας την καρδιακή λειτουργία (ΑΠ και λοιπά ζωτικά σημεία).
3. Για αντιμετώπιση των εμέτων και της τάσης προς έμεση, χορηγείται Μετοκλοπραμίδη (1 amp. *Primperan* 10 mg, iv ή im) ή 1 amp. *Onda* 8 mg, εντός 100 ml NaCl 0,9%.
4. Σε περιπτώσεις εμμένου πυρετού, καθώς και για το έντονο άλγος στον όρχι, χορηγείται 1 fl. *Apotel* 1 gr, στάγδην (iv), εντός 10 λεπτών (ή 1 amp. *Apotel-plus*, im).
5. Εφόσον το άλγος στο όσχεο είναι έντονο ή διάχυτο προς το περίνεο, επιδεινούμενο και μη ανεκτό πλέον από τον ασθενή, χορηγούνται επικουρικώς των ανωτέρω και ΜΣΑΦ. Έτσι, τοποθετείται 1 fl. *Combogesic* ή 1 amp. *Dynastat* 40 mg (ή 1 amp. *Viaxal* 50 mg), εντός 100-250 ml NaCl 0,9%, στάγδην εντός 15-20 λεπτών ή 1 amp. *Vurdon* 75 mg (im).
6. Αντιβιοτικό εκλογής θεωρείται η Κεφτριαξόνη (*Rocephin*) 1 amp. 1-2 gr, ανά 12 ώρες. Εναλλακτικά, χορηγείται Κο-τριμοξαζόλη (*Bactrimel*) 1 amp. 480 mg, ανά 6 ή 8 ώρες.
7. Εφόσον ο ασθενής – με την ενδοφλέβια αντιβιοτική και υποστηρικτική αγωγή – βελτιωθεί κλινικά μετά τις πρώτες 24 ώρες, μπορεί τότε να επιχειρηθεί χορήγηση της αντιβιοτικής και υποστηρικτικής αγωγής από το στόμα (per os), για όσο διάστημα απαιτείται.

Αγωγή κατ' οίκον:

1. Σε ασθενείς με Ο/Ε ιογενούς αιτιολογίας ή με ηπιότερη συμπτωματολογία, χωρίς τοξική εικόνα, σε εξωτερική βάση συνιστάται υποστηρικτική θεραπεία, όπως κλινοστατισμός και ανάπαυση, από του στόματος αγωγή με αναλγητικά, αντιπυρετικά, υπακτικά, καθώς και υποστήριξη τοπικά του οσχέου με ζεστές ή κρύες κομπρέσες για αναλγησία.
2. Εάν υπάρχει υποψία για σεξουαλικά μεταδιδόμενο παθογόνο, τότε η θεραπεία πρέπει να αποτελείται από Κεφτριαξόνη (*Rocephin*): inj. sol. 250 mg εφάπαξ, ενδομυϊκώς και Δοξυκυκλίνη (*Vibramycin*) 100 mg δύο φορές ημερησίως (po), για 10-14 ημέρες. Η Αζιθρομυκίνη (*Zithromax*, *Azirox*) θεωρείται ως μια καλή εναλλακτική επιλογή, αντί της Δοξυκυκλίνης, σε εφάπαξ δόση 1 gr, ήτοι 2 tabs. *Azithromycin* 500 mg (po), άπαξ. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται έλεγχος και θεραπεία και του ερωτικού συντρόφου.
3. Ως αντιβιοτικά 2^{ης} επιλογής και ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία για λοίμωξη από εντεροβακτηριακά [*Gram* (-) *μικρόβια*], μπορεί να χρησιμοποιηθούν (po) τα κάτωθι:
 - Σιπροφλοξασίνη (*Ciproxin/Ladinin*) tab. 500 mg, 1x2, για 7-10 ημέρες.
 - Οφλοξασίνη (*Tabrin*) tab. 300 mg, 1x2, επί 7-10 ημέρες, για ασθενείς < 40 ετών.
 - Λεβοφλοξασίνη (*Tavanic*) tab. 500 mg, 1x1, επί 7-10 ημέρες, για ασθενείς > 40 ετών.
 - Τριμεθοπρίμη-Σουλφαμεθοξαζόλη (*Bactrimel*) tab. 960 mg, 1x2, για 7-10 ημέρες.
4. Η αδυναμία λήψης αντιβιοτικών από το στόμα, τα κλινικά σημεία σήψης και η αποτυχία προηγούμενης θεραπείας εξωτερικών ασθενών, θα πρέπει να οδηγήσουν στην απόφαση για ενδονοσοκομειακή θεραπεία, καθώς και στην άμεση εκτίμηση από ουρολόγο.